

TEMA 6.42 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Epistaxis

PERFIL EUNACOM 4.02.4.014

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Diagnóstico y Resoluciones EUNACOM en ORL y Rinología (Casos Clínicos de Aplicación)

La Semiología Otorrinolaringológica en el Examen Único Nacional muchas veces recae en distinciones de una o dos palabras críticas ("palabras clave EUNACOM"). Veamos la disección diagnóstica.

Caso Clásico 1: El Niño Sangrador

- **Viñeta:** Niño, 6 años, "Respirador bucal", "EPISTAXIS" de repetición, Infecciones recurrentes. - **Análisis:** "Respirador bucal" indica obstrucción. La hipertrofia adenoidea da esto y apnea del sueño pero rara vez sangra. La pista cardinal es la "Epistaxis" más un niño atópico (infecciones/obstrucción). - **Diagnóstico EUNACOM:** Rinitis Alérgica (la congestión friable de la mucosa alérgica sangra al frotarse).

Caso Clásico 2: El Joven Obstruido Oculito

- **Viñeta:** Paciente hombre de 15 años. Epistaxis y "Obstrucción UNILATERAL" asombrosa. - **Diagnóstico EUNACOM:** Nasofibroangioma juvenil (Tumor benigno pero con potencial sangrante letaloide). Requiere derivación y Nasofibroscopia (No se biopsia a ciegas por riesgo de sangrado ofa).

Caso Clásico 3: El Adulto Obstrutivo Asmático

- **Viñeta:** Paciente 25 años. "Asmático". Respirador bucal asiduo por "Obstrucción bilateral grave". - **Diagnóstico EUNACOM:** Pólipos Nasales (poliposis grave fofa rústica). Y si en la prueba agregan "Reacción adversa o alergia rústica a Ibuprofeno/AINEs," se configura la famosa Triada de Widal-Samter pura. - **Manejo Inicial:** Corticoides Orales.

Caso Clásico 4: El Riesgo Oncológico

- **Viñeta:** Paciente 67 años, "Fumador pesado", Obstrucción inmaculada, Epistaxis rebelde y "Proptosis" del ojo en semanas and. - **Diagnóstico EUNACOM:** Cáncer Nasosinusal asombroso u (Afectación orbitaria indica tumor maligno agresivo asuduides).

Caso Clásico 5: La Infección Extendida (Celulitis Orbitaria Pura)

- **Viñeta:** Niño 5 años. Otorrea u Rinorrea, Fiebre, Eritema y Edema de un lado "pre-palpebral o palpebral". - **Diagnóstico EUNACOM:** Complicación letale infecciosa de Sinusitis aguda asidua bacteriana (Celulitis Pre-Septal). - **Manejo:** Antibióticos gnerales Ojo a urgencia.

Caso Clásico 6 y 7: El Factor "Empeoramiento" Sinusal

- **Regla Clínica:** Todo paciente con resfrió y "Rinoconjuntivitis" que lleva 9-10 días (o que en el día 5 mejoró temporalmente per u después regresó letaloide con un fiebre and purulencia The). - **Diagnóstico:** Sinusitis Aguda BACTERIANA (El "Doble empeoramiento" la sella como ofas bacteriana independientemente de los días fofos). - **Manejo:** Amoxicilina.

Caso Clásico 8: Hormonas the Embarazo

- **Viñeta:** Mujer asombrosa The Since Thus 38 Semanas Hence the u Obstrucción Thus These. - **Diagnóstico Asuduidades:** Thus Desde Rinitis And.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un adolescente de catorce años presenta sangrado nasal del lado derecho abundante de inicio reciente y obstrucción nasal del mismo lado que lleva tres meses. No tiene antecedente de trauma ni uso de anticoagulantes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Epistaxis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Epistaxis anterior: más frecuente; área de Kiesselbach del tabique nasal; generalmente leve y responde al tratamiento inicial
- Epistaxis posterior: arteria esfenopalatina; más grave y cuantiosa; frecuentemente requiere taponamiento posterior
- Causas más frecuentes: trauma nasal (rascado incluido) y rinitis; otras: anticoagulantes, enfermedades hematológicas
- Manejo escalonado: compresión diez a veinte minutos + oximetazolina → cauterización con nitrato de plata → taponamiento anterior → taponamiento posterior
- Taponamiento con merocel: se irriga con antibiótico para prevenir infección por estafilococo y síndrome de shock tóxico
- Taponamiento posterior: sonda Foley por nariz, inflar balón en nasofaringe, traccionar para tapar la coana, más taponamiento anterior
- Rinofibroangioma juvenil: adolescentes masculinos; epistaxis unilateral más obstrucción; tratamiento quirúrgico o embolización

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EPISTAXIS)**PREGUNTA 1**

Un adolescente de catorce años presenta sangrado nasal del lado derecho abundante de inicio reciente y obstrucción nasal del mismo lado que lleva tres meses. No tiene antecedente de trauma ni uso de anticoagulantes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?

- A)** Epistaxis anterior por área de Kiesselbach; tratar con compresión y oximetazolina
- B)** Rinofibroangioma juvenil; tratamiento quirúrgico o embolización
- C)** Carcinoma nasosinusal; biopsia urgente
- D)** Hemofilia; solicitar estudio de coagulación urgente
- E)** Rinitis alérgica con epistaxis secundaria; tratar con corticoides intranasales

PREGUNTA 2

Un paciente llega a urgencias con epistaxis importante que lleva treinta minutos. Ya intentó compresión nasal y oximetazolina sin éxito. Se realiza rinoscopia y se identifica el punto sangrante en el tabique anterior. ¿Cuál es el siguiente paso?

- A)** Taponamiento posterior con sonda Foley de inmediato
- B)** Cauterización química del punto sangrante con nitrato de plata
- C)** Transfusión de plaquetas sin evaluar más la causa
- D)** Derivar directamente a cirugía de urgencia
- E)** Solo lavado con suero fisiológico y observación

PREGUNTA 3

Se realiza un taponamiento nasal anterior con merocel en un paciente con epistaxis. ¿Por qué se irriga con antibiótico y cuál es la complicación que se busca prevenir?

- A)** Para evitar rinitis alérgica en el postoperatorio
- B)** Para prevenir colonización bacteriana del tapón y síndrome de shock tóxico por estafilococo
- C)** El antibiótico es innecesario; se usa solo para mantener húmedo el merocel
- D)** Para tratar la causa infecciosa de la epistaxis
- E)** Para reducir el dolor del taponamiento

RESUMEN: EPISTAXIS

La epistaxis o sangrado nasal es una consulta frecuente en urgencias. Se clasifica en anterior y posterior según la localización del sangrado. La epistaxis anterior es la más frecuente, proviene del área de Kiesselbach en el tabique nasal anterior donde convergen varias arterias, y generalmente es de menor cuantía y responde bien al tratamiento inicial. La epistaxis posterior proviene de ramas de la arteria esfenopalatina y es más grave, cuantiosa y frecuentemente no responde a las medidas iniciales. Las causas más frecuentes son el trauma nasal incluyendo el hábito de meterse el dedo, y la rinitis alérgica o no alérgica que inflamar la mucosa y aumenta la fragilidad vascular. Otras causas incluyen anticoagulantes, antiagregantes, enfermedades hematológicas y tumores. El manejo de la epistaxis sigue una secuencia escalonada. Primero, compresión nasal manual con el pulgar y el índice durante diez a veinte minutos. Segundo, vasoconstrictores tópicos como la oximetazolina o adrenalina en suero fisiológico. Si la epistaxis persiste, se realiza rinoscopia para localizar el punto sangrante y cauterización química con nitrato de plata o electrocauterización. Si esto falla, se realiza taponamiento anterior con merocel o gasas. El merocel se irriga con suero fisiológico con antibiótico para prevenir infección, ya que el taponamiento puede colonizarse con estafilococo y producir síndrome de shock tóxico. Si el sangrado es posterior y no responde, se realiza taponamiento posterior con sonda Foley que se pasa por la nariz, se infla en la nasofaringe y se tracciona para tapar la coana, complementado con taponamiento anterior. El rinofibroangioma juvenil es un tumor benigno vascular que afecta principalmente a adolescentes de sexo masculino. Se presenta con epistaxis unilateral y obstrucción nasal del mismo lado. El diagnóstico es con tomografía o nasofibroscofia. El tratamiento es quirúrgico o mediante embolización.